

Классификация детских церебральных параличей

Модуль 5. Гидрореабилитация

✓ **Тема:** История возникновения, классификационные системы и адаптация к интенсивной нейрофизиологической реабилитации

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И EPIDEMIOLOGY

Детский церебральный паралич (ДЦП) — непрогрессирующие моторные и психоречевые нарушения, возникшие в результате поражения головного мозга в пре- и перинатальном периоде онтогенеза нервной системы.

- **Распространённость:** 1,5-2 случая на 1000 живорождённых
- **Риск повышается:** При недоношенности и низком весе при рождении (90 на 1000 при весе <1500 г, до 500 на 1000 у недоношенных младенцев)
- **Течение:** Резидуальное (непрогрессирующее) состояние с возможными изменениями симптоматики в раннем возрасте

Основные причины развития ДЦП:

- Материнские заболевания (гипертоническая болезнь, сахарный диабет, травмы)

- Производственные вредности, стрессы, интоксикации
- Инфекционные заболевания во время беременности
- Осложнения родов и неонатального периода
- Врождённые пороки развития

ИСТОРИЯ КЛАССИФИКАЦИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ПАРАЛИЧЕЙ

XVIII-XIX века: Описания в трудах Гиппократ и К. Галена. Проблема вызвала серьёзное внимание исследователей начиная с XVIII века.

Основные исторические вклады:

Исследователь (год)	Вклад
J. Cazauvelh (1827)	Впервые применил термин «врождённый церебральный паралич» при описании клинко-анатомических параллелей гемиплегий
R. Delpech (1830)	Объединил врождённые двигательные расстройства в клиническую группу «общей мозговой ригидности»
W.J. Little (1853, 1862)	Основоположник изучения проблемы; указал на роль аномальных родов, недоношенности и асфиксии. Дал клиническую характеристику «общей мозговой ригидности»
W. Hammond (1871)	Применил термин «атетоз» для описания насильственных движений пальцев
W. Gowers (1876)	Точно дифференцировал патологические движения; показал наличие хореоформных и дистонических движений у детей
S. Freud (1897)	

	Критически переосмыслил проблему; разделил парезы на 4 типа; разработал концепцию пролонгированной депрессии
W. Phelps (1940-1950)	Разработал классификацию для практического применения; широко использовалась в США
F. Ford (1944)	Разграничил множество синдромов как самостоятельные формы патологии
K. Bobath & B. Bobath (1964-1983)	Предложили классификацию с учётом мышечного тонуса и распределения нарушений (спастическая диплегия, тетрапарез, гемиплегия)

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕТСКИХ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ПАРАЛИЧЕЙ

1. Классификация S. Freud (1897)

Основана на клинических критериях и имеет четыре типа:

I — Собственно болезнь Литтла

Руки парализованы меньше, чем ноги (спастичность)

II — Спастические параличи ног

Минимальное поражение рук (парапаралич)

III — Двусторонняя гемиплегия

Руки поражены больше, чем ноги; мышечная ригидность (сумма гемиплегии, обусловленная двусторонним поражением мозга)

IV — Двусторонний атетоз и общая врождённая хорея

Имеет две фазы развития: паралитическую и позднюю гиперкинетическую

2. Классификация по К. Bobath и В. Bobath (1964-1983)

Спастические формы:

- Диплегия спастическая (поражены преимущественно ноги)
- Тетрапарез (спастический) с вариантами
- Гемиплегия спастическая (односторонний паралич)
- Моноплегия спастическая
- Парапарезия спастическая (диплегия с лёгким поражением рук)

Не спастические формы:

- Гиперкинетическая форма (двойной атетоз, атетоз, хорей)
- Атактическая форма (нарушение координации, мозжечковая атаксия)
- Смешанные формы (спастико-атактическая, спастико-гиперкинетическая, атактико-гиперкинетическая)

3. Классификация К.А. Semenova (1978) — Современная в России

- Спастическая диплегия (Болезнь Литтла)
- Двойная гемиплегия
- Гиперкинетическая форма
- Атонически-астатическая форма
- Гемиплегическая форма

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЦП ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Новая система интенсивной реабилитации показала высокую эффективность. Для объективизации процесса необходима классификация ДЦП, адаптированная к реабилитационному процессу.

Три ведущих синдрома при диагностике:

1. Синдром двигательных нарушений
2. Синдром нарушений интеллекта
3. Синдром речевых расстройств

Синдром двигательных нарушений характеризуется:

Выраженность пирамидных нарушений:

- Парез (слабость или ограничение движений)
- Плегия (полное отсутствие движений)

Распространённость (локализация):

- Моно- (одна конечность)
- Пара- (две симметричные конечности)
- Три- (три конечности)
- Тетра- (четыре конечности)
- Гемиплегия (парез)

Тип мышечного тонуса:

- **Гипертония мышц (спастика, ригидность):**
 - Повышенный мышечный тонус сопротивляется пассивному движению в обследуемой группе мышц

- Высокий мышечный тонус — сопротивление достаточно сильное
- Ригидоспастика — сопротивление всему движению
- Ригидность — практически невозможное движение
- **Гипотония:** Снижение мышечного тонуса (способствует рекурвации и гипермобильности суставов)
- **Дистония:** Характеризуется колебаниями мышечного тонуса (дистонические атаки)

Стадии локомоторного развития:

Стадия	Характеристика
Отсутствие передвижения	Ребёнок полностью зависит от помощи
Передвижение переворотом	Передвижение осуществляется поворотом туловища
Ползание по-пластунски	Самостоятельное передвижение с использованием рук
Ползание скачками	Использование четвёрорукного способа движения
Альтернирующее ходьба	Попеременное движение ног при поддержке
Ходьба на коленях	Самостоятельное передвижение на коленях
Ходьба со вспомогательными устройствами	Ходьба с помощью костылей, тростей или коляски
Самостоятельная патологическая ходьба	Ходьба с нарушениями паттерна движения

Фазы вертикализации:

- Лежание без контроля головы
- Лежание с контролем головы

- Самостоятельное сидение
- Вставание возле опоры
- Вставание самостоятельное

Синдром нарушений интеллекта:

Задержка психического развития лёгкой степени:

Психическое развитие всего на несколько месяцев отстаёт от нормы

Выраженная задержка психического развития:

Отставание на 1-2 года

Синдром речевых расстройств:

- **Задержка речевого развития**
- **Алалия** (сенсорная, моторная или смешанная)
- **Дизартрия** (спастическая, гиперкинетическая, атактическая, смешанная)

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Резидуальное состояние — состояние, которое остаётся у человека после перенесённых заболеваний, травм или других повреждений мозга или ЦНС. Требует специальных методов обследования.

Гемиплегия — полная потеря возможности произвольных движений (паралич) в ноге и руке с одной стороны тела.

Атетоз — гиперкинез (патологические непроизвольные движения), выражающийся медленной тонической судорогой конечностей, лица, туловища.

Диплегия — одна из форм детского церебрального паралича, затрагивающая симметричные части тела. Отличается от гемиплегии, которая относится к спастичности, ограниченной одной стороной тела, парапаралич, параллегии, которая относится к параличу, ограниченному ногами и тазобедренным суставом, квадриплегии, которая требует вовлечения всех четырёх конечностей.

Хорея — нерегулярные, отрывистые, беспорядочные, хаотичные, иногда размахистые, бесцельные движения, возникающие преимущественно в конечностях. Происходит от греческого слова χορεία, означающего «танец».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Классификация детских церебральных параличей необходима для:

- Формулирования гипотезы о причинах поражения мозга
- Разработки профилактических мероприятий
- Понимания природы дефекта при определённых неврологических нарушениях
- Разработки лечебно-коррекционных мероприятий
- Прогноза и обучения, определения трудоспособности и степени инвалидности

Современная система интенсивной реабилитации показала высокую эффективность при лечении больных ДЦП. Развитие новых знаний позволит выделить группы с идентичными этиологическими,

патологоанатомическими и клиническими признаками
для более эффективного подхода к реабилитации.

Лекционный материал | Модуль 5. Гидрореабилитация

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика
М.Ф. Решетнева